



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PROGRAM KERJA
INSTALASI KAMAR OPERASI
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026

PROGRAM KERJA INSTALASI KAMAR OPERASI TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Instalasi kamar operasi adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pembedahan, anestesi & sedasi ringan, sedang dan dalam untuk memenuhi kebutuhan pasien baik untuk tindakan elektif maupun emergensi di luar jam kerja. Sebagai salah satu bagian dari Rumah Sakit Prima Husada. Instalasi Kamar Operasi memberikan pelayanan tindakan pembedahan, anestesi maupun sedasi dengan dilengkapi peralatan yang memadai dan juga di dukung oleh SDM yang memiliki sertifikasi dan pelatihan yang khusus dibidangnya serta memenuhi persyaratan dan standar di rumah sakit, nasional, undang – undang, dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pelayanan pembedahan dan anestesi harus selalu terjamin mutunya.

1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/MENKES/PER/II/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standart Pelayanan Kedokteran;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
- 6) Pedoman Manajemen Linen di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI tahun 2004;
- 7) Pedoman Teknis Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Departemen Kesehatan RI Tahun 2007;
- 8) Pedoman Instalasi Pusat Steril di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI tahun 2009;
- 9) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

10) Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Program kerja kamar operasi disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pembedahan yang aman, efektif, efisien, dan sesuai standar. Program ini menjadi acuan bagi seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di kamar operasi dalam melaksanakan tugas, mengelola sumber daya, serta menjaga mutu pelayanan.

2) Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas pelayanan kamar operasi sehingga tindakan pembedahan dapat dilakukan secara aman, tepat, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

3) Tujuan Khusus

- A. Meningkatkan kualitas pelayanan pasien bedah.
- B. Meningkatkan kuantitas pelayanan bedah.
- C. Memastikan semua karyawan Instalasi Kamar Operasi mengetahui praktek bedah yang baik, sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi nosokomial dan terhindar dari bahaya kecelakaan kerja.



-
- D. Memastikan agar peralatan Instalasi Kamar Operasi dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan Instalasi Kamar Operasi.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 VISI

“Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 MISI

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 MOTTO

“Sahabat menuju sehat”

2.4 (7) NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur dipercaya
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK





BAB II

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Melakukan perencanaan kebutuhan SDM 2) Melakukan orientasi staf baru 3) Meningkatkan kompetensi staf melalui pendidikan dan pelatihan 4) Mengusulkan kredensial dan rekredensial 5) Melakukan penilaian kinerja staf 6) Mengatur shift dan beban kerja
2	Pengembangan pelayanan	1) Tersedianya alat dan BHP untuk operasi lain 2) Promosi Kesehatan dengan PKRS diruang tunggu 3) Jumlah pasien operasi meningkat
3	Melakukan Pelayanan Kamar Operasi	1) Melaksanakan Pelayanan kamar operasi a. Melakukan operasi sesuai dengan standart operasional prosedur b. Melakukan supervisi ruangan c. Melakukan pemeliharaan alat medis dan non medis d. Melakukan bongkaran setiap satu minggu sekali e. Pelaksanaan kendali mutu internal f. Pelaksanaan kendali mutu eksternal 2) Melaksanakan Pelayanan kamar operasi a. melakukan pelayanan operasi endourologi b. melakukan pelayanan operasi endo THT c. melakukan pelayanan operasi dengan c-arm
4	Melaksanakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan serta K3	1) form pemeliharaan alat terisi lengkap 2) Alat terkalibrasi 3) Set Instrumen Bedah Plastik dan bedah saraf 4) Set Instrumen 5) Linen Operasi
5	Meningkatkan Mutu Pelayanan kamar operasi Sasaran Keselamatan Pasien	1) Melaksanakan Pengukuran IMP-RS a. Kepatuhan Identifikasi pasien b. Kepatuhan kebersihan tangan c. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh d. Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit e. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 2) Melaksanakan Pengukuran IMP Instalasi Kamar operasi a. Kepatuhan identifikasi pasien b. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR



NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		c. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert d. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien e. Kepatuhan kebersihan tangan f. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh
5	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	a. <i>Scrubing</i> b. <i>Gowning</i> c. <i>Gloving</i> d. Kelayakan Ruang Operasi e. Uji Kebersihan dan Kelayakan Ruang Operasi
6	Melaksanakan promosi Kesehatan	1) Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga (100%)
		2) Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl) di depan ruang tunggu operasi
		3) Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio RS, Medsos)
7	Melaksanakan MONEV	1) Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk 2) Melaksanakan Rapat Unit - Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen, program
8	Membuat Laporan	1) Membuat Laporan kinerja kamar operasi bulanan 2) Membuat Laporan kinerja kamar operasi triwulan 3) Membuat Laporan kinerja kamar operasi semester 4) Membuat Laporan kinerja kamar operasi tahunan

3.2 SASARAN

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Sumber Daya Manusia (SDM)						
1)	Melakukan perencanaan kebutuhan SDM	Menjamin ketersediaan tenaga yang memadai dan kompeten sesuai beban kerja	Tersusunnya dokumen kebutuhan SDM berbasis Analisa Beban Kerja (ABK) setiap tahun	Analisa beban kerja	Dokumen ABK selesai sebelum penyusunan RKA	Tersedianya ABK tertulis (100%), selisih antara kebutuhan dan staf $\leq 10\%$.	
2)	Melakukan orientasi staf baru	Mempercepat adaptasi staf baru terhadap pelayanan di kamar operasi	100% staf baru mengikuti orientasi	Sesi orientasi unit, tour IKO, pengenalan SOP, PPI & K3	100% staf baru melakukan orientasi	Prosentase staf baru yang hadir 100%	
3)	Meningkatkan kompetensi staf melalui pendidikan dan pelatihan	Menjaga & meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis staf	Minimal mempunyai sertifikat instrumen dan anastesi	Workshop, e-learning	100% staf mengikuti minimal 5 program pelatihan dan workshop	Prosentase staf tersertifikasi/ikut pelatihan $\geq 90\%$	
4)	Melakukan kredensial dan rekredensial	Memastikan staf mempunyai kompetensi terverifikasi untuk tugas klinis.	Semua analis dan petugas teknik terekredensial sesuai tugas	Verifikasi dokumen pendidikan, observasi praktis, CAT/tes praktikum.	Kredensial saat awal penugasan; rekredensial minimal 1x/tahun.	Prosentase staf dengan kredensial valid $\geq 95\%$; temuan kompetensi kritis = 0.	
5)	Melakukan penilaian kinerja staf	Mengukur kinerja staf untuk pengembangan dan akuntabilitas.	Penilaian kinerja terjadwal (tahunan/semester).	Penilaian kinerja	Penilaian selesai sesuai jadwal; rencana pengembangan dibuat untuk yang <standar	Prosentase penilaian selesai $\geq 100\%$	
6)	Mengatur shift dan beban kerja	Menjamin ketersediaan layanan, mencegah	Jadwal shift terstruktur & adil; beban kerja terkendali.	Penyusunan jadwal	Jam kerja sesuai ketentuan	Tingkat absensi <5%	

		fatigue, dan patuhi aturan kerja.					
2	Pegembangan Pelayanan						
	a. Pendataan inventaris alat medis dan non-medis	Mengetahui ketersediaan dan kondisi aset untuk perencanaan pemeliharaan/pengadaan	Daftar inventaris lengkap & ter-update	Stock opname	100% alat tercatat dalam sistem	semua item memiliki status	
	b. Pemeliharaan alat	Menjamin alat berfungsi akurat & menurunkan downtime	Jadwal PM berjalan, perbaikan terekam	PM berkala, kalibrasi,	PM sesuai rekomendasi pabrik; downtime tahunan <10% jam operasi.	Prosentase PM terlaksana sesuai jadwal ≥95%	
	c. Pengelolaan lingkungan kerja	Menjaga kondisi lingkungan yang sesuai untuk keandalan pemeriksaan dan keselamatan.	Suhu/kelembapan terkontrol; area bersih & aman	Monitoring log suhu, pembersihan berkala	Hasil monitoring lingkungan memenuhi spesifikasi penyimpanan.	Prosentase hari log suhu lengkap ≥95%	
3	Pelayanan Kamar Operasi						
	a. Penggunaan alat di kamar operasi	Monitoring supervisi pelayanan pembedahan dan anastesi	Kontrol harian dan minggu/ bulan	Penggunaan kontrol	Kontrol pemakaian harian alat	- Prosentase hari kontrol dalam batas ≥95% - Tindakan korektif terdokumentasi.	
	b. Implementasi dan audit kepatuhan Surgical Safety Checklist WHO	Menilai kepatuhan ssc	Semua staf onlop	Analisa melakukan ssc	Hasil 100% melakukan ssc	Kepatuhan checklist ≥95%	
	c. Verifikasi identitas pasien	Memastikan kepatuhan terhadap Verifikasi	Supervisi setiap hari/minggu/ bulan	Pengukuran rutin, dashboard mutu	Audit terselesaikan; semua temuan mendapat RTL	Prosentase indikator mencapai target ≥90%.	

	sebelum operaso	identitas pasien sebelum operasi					
	d. Monitoring angka infeksi daerah operasi (IDO)	Memastikan kepatuhan terhadap SOP & standar	Kepatuhan tentang cuci tangan dan pemakaian apd sesuai standart	Pengukuran rutin, dashboard mutu	Audit terselesaikan; semua temuan mendapat RTL	Prosentase temuan tertutup dalam waktu (mis. 30 hari) ≥90%	
	e. Survei kepuasan pasien & dokter pengguna	Mengidentifikasi area perbaikan layanan berbasis pengguna.	Survei minimal 1x/tahun	Kuesioner	Skor kepuasan ≥80%	Kenaikan skor kepuasan >5% per tahun setelah intervensi	
	f. Penyusunan & evaluasi SPO pelayanan	Menjaga konsistensi pelaksanaan pemeriksaan sesuai SOP	Semua proses utama memiliki SPO terdokumentasi dan di-review minimal 1x/tahun	Penyusunan SOP, review berkala, sosialisasi	100% proses kritis tertutup oleh SOP; review tahunan.	Prosentase SOP yang di-review dan disetujui 100%	
4	Sasaran Keselamatan Pasien						
	a. Identifikasi pasien	Mencegah kesalahan spesimen/hasil.	100% spesimen teridentifikasi	Verifikasi ID saat pendaftaran & label	Kesalahan identifikasi = 0 kasus	Prosentase spesimen dengan ID lengkap ≥99.9%; incident mislabel = 0	
	b. Komunikasi efektif hasil kritis	Menjamin penanganan segera atas hasil yang mengancam pasien	Penyampaian hasil ke klinik dalam waktu ≤10 menit	SOP pelaporan	100% hasil kritis dilaporkan sesuai SOP	Prosentase laporan kritis yang terdokumentasi ≤10 menit ≥95%	
	c. Meningkatkan kewaspadaan obat yang perlu diwaspasai	Mengurangi risiko kesalahan pemberian obat	Penempelan stiker LASA & High Alert	Penyusunan SOP, review berkala, sosialisasi	Tidak ada kejadian kesalahan akibat pemberian obat	Insiden kesalahan 0	
	d. Penerapan hand hygiene dan APD	Mencegah transmisi infeksi pada pasien & staf.	Kepatuhan hand hygiene & penggunaan APD ≥90%	Pelatihan, audit kepatuhan	Kepatuhan ≥90% pada audit berkala.	Prosentase kepatuhan audit hand hygiene ≥90%	

	e. Pengurangan risiko pasien jatuh di area iko	Menjamin keselamatan pasien di area pelayanan kamar operasi.	Area aman & bebas hambatan	Pemeriksaan area	Insiden jatuh di area lab = 0	Jumlah insiden jatuh = 0	
5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)						
	a. Staf tertusuk jarum	Menggunakan teknik one hand untuk memegang jarum	Pembacaan spo	Matriks risiko	di-review 1x/bulan.	Prosentase risiko mitigasi yang diimplementasikan $\geq 90\%$	
	b. Staf terkena darah pasien	Penggunaan APD setiap melakukan tindakan	Pembacaan SPO	Pengelolaan	Kepatuhan 100% terhadap peraturan pemakaian APD	Nol insiden paparan darah	
	c. Staf terpeleset/terjatuh	Mendeteksi kejadian adanya air menggenang	Sistem pelaporan insiden	Laporan paparan	100% insiden dilaporkan & mendapat tindak lanjut	Penurunan insiden tahunan.	
	d. Staf ter Setrum	Meningkatkan kesiapsiagaan tim terhadap kejadian	Pembacaan SPO	Penggunaan wajib sesuai SPO	Drill dilakukan, evaluasi & perbaikan tercatat.	Evaluasi drill menunjukkan perbaikan tindakan	
	e. Salah lokasi daerah operasi	Memantau sebelum melakukan tindakan pembedahan	Dpjp wajib melakukan pra bedah sebelum melakukan tindakan	Semua tindakan sudah ditandai jika ada 2 regio	100% dpjp melakukan pra bedah	100% pasien sudah di lakukan pra bedah	
	f. Infeksi luka operasi	Memantau alat dan linen sesuai indikator	Perawat instrumen wajib melihat tanggal kadaluarsa alat	Ssc wajib 100% dijalankan	100% perawat bedah melakukan ssc	100% pasien sudah di lakukan ssc	
	g. Alat dan bakteri mengembang saat ac bocor/ tidak dingin	Meantau suhu ruangan kamar operasi	Semua staf wajib melihat suhu ruangan	Suhu ruangan standart 17-18 derajat selcius	Staf melakukan pencatan suhu ruangan	100% di lakukan setiap hari	
6	Pencegahan dan pengendalian infeksi						
	a. Monitoring kepatuhan hand hygiene	Kepatuhan staf dalam hand hygiene	Kepatuhan wajib 100%	Sosialisasi, SOP, audit kepatuhan	Kepatuhan hand hygiene $\geq 95\%$	Audit kepatuhan $\geq 95\%$	

	b. Observasi penggunaan APD	Kepatuhan staf dalam penggunaan APD	Kepatuhan wajib 100%	Sosialisasi, SOP, audit kepatuhan	Kepatuhan hand hygiene $\geq 95\%$	Audit kepatuhan $\geq 95\%$	
	c. Sterilisasi alat dan linen	Menjamin peralatan steril & aman	Protokol sterilisasi terdokumentasi & dijalankan oleh ccscd	Validasi proses sterilisasi	Proses sterilisasi tervalidasi	Tidak ada infeksi terkait alat	
	d. Surveilans Infeksi Daerah Operasi (IDO)	Tidak ada terjadinya IDO	Protokol sterilisasi, hand hygiene, dan penggunaan APD	Sosialisasi, SOP, audit kepatuhan	Kepatuhan $\geq 95\%$	Audit kepatuhan $\geq 95\%$	
	e. Monitoring kebersihan lingkungan kamar operasi	Menjamin ruangan selalu bersih dan steril	Kepatuhan pre clining setelah melakukan operasi	Sosialisasi, SOP, audit kepatuhan	Kepatuhan $\geq 95\%$	Audit kepatuhan $\geq 95\%$	
7	Melaksanakan MONEV						
1)	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk	Memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan	Kepala Ruang	Internal	Supervisi : Setiap hari Evaluasi : 1 bulan sekali	Laporan Supervisi dan Evaluasi Kinerja	
2)	Melaksanakan Rapat Unit	Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas di dalam satu unit kerja.	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Umandok rapat unit	
3)	Menghadiri Rapat Koordinasi antar	Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Umandok rapat koordinasi	

	unit, manajemen, program	meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas di dalam kinerja.					
9	Membuat Laporan						
1)	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)	Mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan selama satu bulan.	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Laporan bulanan	

3.3 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Sumber Daya Manusia (SDM)						
	a. Perencanaan kebutuhan staf	Analisis beban kerja, jumlah pasien, cakupan layanan, shift, kompetensi & rasio kebutuhan SDM; menyusun usulan kebutuhan ke direktur	Perhitungan ABK	Form ABK, data kunjungan pasien, daftar SDM, rancangan jadwal	1 kali per tahun + bila ada pengembangan layanan	Dokumen analisis ABK	
	b. Orientasi staf baru	Pengenalan visi-misi, struktur, alur pelayanan, SKP, PMKP, PPI, K3, risiko, peralatan, LIS, dan SPO	Presentasi, mentoring dan bedside training	daftar SOP, video	Pada hari pertama masuk kerja sampai 1–2 minggu	absensi orientasi, sertifikat	
	c. Peningkatan kompetensi staf	Pelatihan internal, workshop eksternal, in house training, seminar, pembelajaran mandiri	Diklat + mentoring kompetensi + peer review	PPT, alat laboratorium, daftar pelatihan	Minimal 2 kali/tahun	Sertifikat pelatihan, laporan kegiatan	
	d. Penilaian kinerja staf	Penilaian kinerja individu, kedisiplinan, mutu kerja, kepatuhan PPI/K3, perilaku kerja	Penilaian kinerja berbasis indikator	Form penilaian	Setiap 6 bulan	Laporan penilaian kinerja, tindak lanjut pembinaan	

	e. Pengaturan shift dan beban kerja	Penyusunan jadwal shift merata sesuai kapasitas SDM, kompetensi, keselamatan kerja & kebutuhan pelayanan	Shift scheduling	Jadwal shift, aplikasi / Excel	Dibuat tiap bulan	Jadwal shift yang ditandatangani Kepala Unit, Kabid	
2	Pengembangan Pelayanan						
	a. Pendataan inventaris alat medis dan non-medis	Pendataan alat, pengelompokan, pemberian kode aset, pencatatan lokasi & kondisi	Inventarisasi fisik & administrasi	Kartu inventaris, database	1x/tahun & update bila ada alat masuk/keluar	Daftar inventaris,	
	b. Pemeliharaan alat	Preventive maintenance, corrective maintenance, kalibrasi & pemantauan fungsi alat	Perawatan oleh vendor & teknisi	Logbook alat, jadwal maintenance, surat kalibrasi	Bulanan / tahunan sesuai alat	Laporan pemeliharaan & sertifikat kalibrasi	
	c. Pengelolaan lingkungan kerja	Menjaga kondisi lingkungan yang sesuai untuk keandalan pemeriksaan dan keselamatan.	Suhu/kelembapan terkontrol; area bersih & aman	Monitoring log suhu, pembersihan berkala	Hasil monitoring lingkungan memenuhi spesifikasi penyimpanan.	Prosentase hari log suhu lengkap $\geq 95\%$	
3	Mutu Pelayanan						

1)	Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) a. Kepatuhan identifikasi pasien b. Kepatuhan kebersihan tangan c. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh d. Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit e. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri f. Kepatuhan identifikasi pasien	Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit , peningkatan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya angka IKP	1. Staff IKO 2. PIC Mutu	internal	Sesuai standart a. 100% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100% f. 100%	Tidak adanya IKP	
2)	g. Kejadian ketidaksesuaian diagnosa pre dan post operasi h. Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO i. Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi j. Angka kelengkapan laporan operasi di IKO k. Kejadian tidak dilakukannya	Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit , peningkatan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya angka IKP	1. Staff ICU PIC Mutu	Internal	Sesuai standart g. 0 kejadian h. 100% i. 100% j. 100% k. 100% l. 100% m. 100% n. 100% o. $\leq 6\%$ p. $\leq 6\%$ q. $\leq 6\%$ r. 0 s. 0 t. 0	Tidak adanya IKP	

Penandaan pada pasien operasi l. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi m. Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi n. Kepatuhan pengembalian obat sisa anestesi & narkotika ke ruang farmasi o. Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis p. Kejadian reaksi anestesi q. Kejadian salah penempatan pasien r. Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi s. Kejadian konversi dari regional anestesi ke general anestesi t. Kejadian efek samping selama sedasi moderat				u. 0 v. 0		
---	--	--	--	-------------------------	--	--

	u. Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi v. Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi						
4	Sasaran keselamatan pasien						
	a. Identifikasi pasien	Siapkan identitas,lakukan identifikasi ulang dengan pasien, verifikasi identitas dengan lembar kerja,waspadaai pasien dengan nama yang sama dengan nomer rm pasien.	Dua identitas pasien	Label gelang	Setiap pelayanan	Audit kepatuhan	
	b. Komunikasi Efektif	Lakukan komunikasi 2 arah, penyampaian yang jelas, validasi, ringkas komunikasi	Readback & SBAR	hasil	Real time	Rekap hasil	
	c. Pengelolaan bahan berisiko tinggi	Identifikasi bahan, pemakaian APD, penggunaan dan pengelolaan, penanganan tumpahan, pemusnahan	Pelabelan & penyimpanan aman	Wadah & label bahaya	Harian	Log bahan berisiko	

		limbah, dokumentasi dan pelaporan					
	d. Hand hygiene dan APD	Dilakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan handwash dan handrub	Kepatuhan 5 momen	Poster APD	Harian	Audit kepatuhan	
	e. Risiko jatuh	Lakukan skrining resiko jatuh, kategorikan resiko jatuh	Rambu, pendampingan	Poster risiko jatuh	Harian	Audit risiko jatuh	
5	Kesehatan dan Keselamatan Kerja						
	a. Identifikasi dan penilaian risiko	Identifikasi resiko, penilaian resiko, penetapan resiko, monev.	Identifikasi risiko	Form identifikasi risiko	1x/tahun	Dokumen	
	b. Pengelolaan limbah B3 dan tajam	Identifikasi limbah, pemilahan limbah, pengumpulan dan penyimpanan sementara, pengolahan, pengangkutan eksternal, dokumentasi dan penggunaan APD.	Safety box, label	Kantong limbah & safety box	Harian	limbah B3	
	c. Pemantauan paparan risiko kerja	Laporan, SOP, dokumentasi, monev	Pelaporan insiden	Form K3	Bila ada kejadian	Laporan insiden	
	d. Simulasi K3	Tujuan simulasi, bentuk tim pelaksana, skenario simulasi, fasilitas dan peralatan, evaluasi, laporan	Simulasi tumpahan / kebakaran	APAR & spill kit	1x/tahun	Laporan simulasi	
	e. Pemeriksaan kesehatan staf	Dilakukannya kegiatan skrining kesehatan staff, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, interpretasi dan	MCU	Form MCU	1x/tahun	Rekap MCU	

		penilaian kerja, dokumentasi dan pelaporan					
6	Pencegahan dan pengendalian infeksi						
	a. Kewasapadaan universal	Pengunaan APD, Handhygiene, penanganan peralatan B3 dan benda tajam, pengelolaan limbah, dekontaminasi, penanganan paparan, edukasi dan dokumentasi	Observasi kepatuhan	SOP PPI, alat/APD	Harian	Audit kepatuhan	
	b. Pengendalian lingkungan	Identifikasi sumber bahaya, pemantauan lingkungan, perbaikan lingkungan, pelatihan staff, evaluasi berkala, dan dokumentasi	Disinfeksi	Larutan desinfektan	Harian	Log desinfeksi	
	c. Manajemen limbah infeksius	Identifikasi limbah, pengumpulan limbah, penyimpanan sementara, transportasi limbah, pemusnahan , dokumentasi.	Pemilahan & serah ke petugas limbah	Kantong merah	Harian	Form serah limbah	
	d. Pelaporan infeksi nosokomla	Penentuan kasus yang harus dilaporkan, pengumpulan data kasus, validasi kasus, rekapitulasi data, analisis, laporan berkala, penyampaian laporan dan tindak lanjut.	Laporan ke IPCN	Form surveilans	Bila ada kasus	Rekap surveilans	
7	Melaksanakan MONEV						
1)	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program	Melakukan monitoring supervisi dan evaluasi	Supervisi Evaluasi	Spread sheet	1) Setiap hari 1x/bulan	1) Setiap hari 1x/bulan	

	a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS Manrisk						
2)	Melaksanakan Rapat Unit	Melakukan rapat unit	Umandok	Laporan	2) 1x/bulan	2) Setiap 1 bulan sekali	
3)	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen, program	Melakukan rapat koordinasi antar unit, manajemen, program	Umandok	Laporan	3) 1x/bulan	3) Setiap 1 bulan sekali	
8	Membuat Laporan						
1)	Membuat laporan (bulanan, tahunan)	Melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan	Laporan	Laporan	1 bulan sekali dan 1 tahun sekali	Laporan bulanan dan laporan tahunan	

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

No	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Meningkatkan SDM ICU																		
1)	Menghitung Kebutuhan SDM	1. SDM 2. Staff IKO														IKO	Karu	PT.DPM	
2)	Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru		Sesuai SDM												IKO	Karu	PT.DPM		
3)	Membuat penilaian Kinerja staf															IKO	Karu	RS	
4)	Melaksanakan Diklat terkait akreditasi (mengikuti SDM)															R. Diklat	SDM	PT.DPM	
5)	Melaksanakan Diklat IKO 1. Pelatihan Instrumen 2. Refresmen Pelatihan anastesi															menyesuaikan	SDM	PT.DPM	
2	Pengembangan Pelayanan																		
1)	Pendataan inventaris alat medis dan non-medis	Seluruh pasien pasien IKO														R. IKO	Seluruh Staf IKO	RS	
2)	Pemeliharaan alat	Seluruh pasien pasien IKO																	
3)	Pengelolaan lingkungan kerja	Seluruh pasien pasien IKO																	
3	Mutu Pelayanan																		

1)	Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) a. Kepatuhan identifikasi pasien b. Kepatuhan kebersihan tangan c. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh d. Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit e. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Kepatuhan identifikasi pasien	Seluruh staf IKO													R. IKO	PIC Mutu Komite Mutu	RS	
2)	Kejadian ketidaksesuaian diagnosa pre dan post operasi h. Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO i. Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi j. Angka kelengkapan laporan operasi di IKO k. Kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi l. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	Seluruh staf IKO													R. IKO	PIC Mutu Komite Mutu	RS	

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

1)	Identifikasi pasien	Seluruh staf IKO														R. IKO	Karu IKO	PT.DPM	
2)	Komunikasi Efektif	Seluruh staf IKO															R. IKO	KARU IKO	RS
3)	Pengelolaan bahan berisiko tinggi	IPSRS Gudang Farmasi															R. IKO	IPSRS Pengadaaan PT	RS
4)	Hand hygiene dan APD	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC PPI Komite PPI	RS
5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja																			
1)	Identifikasi dan penilaian risiko	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC Mutu Komite Mutu	RS
2)	Pengelolaan limbah B3 dan tajam	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC PPI Komite PPI	RS
3)	Pemantauan paparan risiko kerja	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC Mutu Komite K3RS	RS
4)	Pemantauan paparan risiko kerja	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC Mutu Komite K3RS	RS
5)	Pemeriksaan kesehatan staf	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC Mutu Komite K3RS	RS
6)	Simulasi K3	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC Mutu Komite K3RS	RS
6. Pencegahan dan pengendalian infeksi																			
1)	a) Kewaspadaan universal	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC PPI Komite PPI	RS
2)	Pengendalian lingkungan	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC PPI Komite PPI	RS
3)	Manajemen limbah infeksius	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC PPI Komite PPI	RS
4)	Pelaporan infeksi nosokomila	Seluruh staf IKO															R. IKO	PIC PPI Komite PPI	RS
7. Melaksanakan program PKRS																			

1)	Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga	Seluruh pasien dan keluarga IKO														R. IKO	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
2)	Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl)	Seluruh keluarga pasien IKO														R. IKO	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
3)	Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial)	Seluruh keluarga pasien IKO														R. IKO	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
4)	Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. IKO	Seluruh keluarga pasien IKO														R. IKO	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
8.	Melaksanakan MONEV																		
1)	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk	Kepala Ruang IKO														R.IKO	Karu IKO	RS	
2)	Melaksanakan Rapat Unit	Kepala Ruang IKO														R.IKO	Karu IKO	RS	
3)	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen, program	Kepala Ruang IKO														R.IKO	Karu IKO	RS	
9	Membuat laporan																		
1)	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)	Kepala Ruang IKO														R.IKO	Karu IKO	RS	

3.5. Kebutuhan Anggaran

Tabel 3.5 Kebutuhan Anggaran

No	Nama Alat	Stok Unit	Pengajuan	Utilitas Rata ² / Bulan	Harga @Alat	Total
1	Alat instrumen avisan	0	1	Menunggu unit HD	Rp 148.750.000	Rp 148.750.000
2	Sandal tim	20	10 ukuran (44)	210 jam/ bulan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
					TOTAL	Rp. 149.950.000

Tabel 3.6 Kebutuhan Biaya Pengembangan

No	Kegiatan	Internal/ Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Tersedianya depo farmasi di IKO	Internal	Menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan
2	Lakukan pelatihan keselamatan dan keamanan kerja	Internal	15 orang	Rp 10.000	Rp 150.000
3	Pelatihan Manajemen Kamar Bedah	External	2 orang	Rp 5.500.000	Rp 11.000.000
4	Update Sertifikasi perawat anastesi	External	3 orang	Rp. 5.500.00	Rp. 16.500.000
				TOTAL	Rp 30.150.000

Tabel 3.7 Kebutuhan Anggaran Pemeliharaan Unit

No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kegiatan		Target Pelaksanaan	Unit Pelaksana
			Kalibrasi	Uji Kelayakan/ Uji Kebersihan		
1	Mesin Anastesi Standart (Mindray/ WATO EX-35)	1	√		September 2025	IPSRS
2	Mesin Anastesi Standart (Mindray/ WATO EX-20)	1	√		September 2025	IPSRS
3	Mesin Anastesi (Softlander SL-210)	1	√		September 2025	IPSRS
4	Mesin Anastesi Standart (Mindray/ WATO EX-35)	1	√		September 2025	IPSRS
5	Lampu Operasi (Steris Harmony vLED)	1	√		September 2025	IPSRS
6	Lampu Operasi (Panalex/LED 2)	1	√		September 2025	IPSRS
7	Lampu Operasi (Panalex/LED 3)	1	√		September 2025	IPSRS
8	Lampu Operasi (Panalex/LED 4)	1	√		September 2025	IPSRS
9	Electrocouter (Onemed/ Zeus-400/300/200)	1	√		September 2025	IPSRS
10	Electrocouter (Onemed/ Zeus-400/300/201)	1	√		September 2025	IPSRS
11	Electrocouter (Endo/Zeus)	1	√		September 2025	IPSRS
12	Electric Suction (Onemed/ YB-DX23B)	1	√		September 2025	IPSRS

13	Electric Suction (Onemed/ 7A-23B)	1	√		September 2025	IPSRS
14	Electric Suction (Gea Medical/ YX930D)	1	√		September 2025	IPSRS
15	Electric Suction (Gea Medical/ YX90D)	1	√		September 2025	IPSRS
16	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-91038002)	1	√		September 2025	IPSRS
17	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-85024960)	1	√		September 2025	IPSRS
18	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-89032531)	1	√		September 2025	IPSRS
19	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-91038010)	1	√		September 2025	IPSRS
20	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-91038010)	1	√		September 2025	IPSRS
21	Monitor Pasien (AM 1200 / Analugic Medical)	1	√		September 2025	IPSRS
22	Monitor Pasien (Inter UP5000)	1	√		September 2025	IPSRS
23	Infus Pump (Mindray/ SK-600)	1	√		September 2025	IPSRS
24	Syringe Pump (Mindray/ SK-500)	1	√		September 2025	IPSRS
25	Infuse Warmer (Animec/ AM-301)	1	√		September 2025	IPSRS
26	Infant Warmer (Gea Medical/ HKN-90)	1	√		September 2025	IPSRS
27	Suction Apparatus (General Care/7E-A)	1	√		September 2025	IPSRS
28	Dental Aerosol System (Coxo)	1	√		September 2025	IPSRS
29	Dental Implantmed (W&H/SI-1023)	1	√		September 2025	IPSRS
30	Operating Microscop (Takagi/OM-9)	1	√		September 2025	IPSRS
31	Mesin Phaco (Alcon)	1	√		September 2025	IPSRS
32	Mesin Endoskopi Urologi (Maxer Germany)	1	√		September 2025	IPSRS
33	Tensimeter Digital (Happy Sheep)	1	√		September 2025	IPSRS
34	Electric Suction (Gea Medical/ YX90D)	1	√		September 2025	IPSRS
35	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-91038002)	1	√		September 2025	IPSRS
36	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-85024960)	1	√		September 2025	IPSRS
37	Monitor Pasien (Mindray/ uMEC10/KN-89032531)	1	√		September 2025	IPSRS

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

Jadwal kegiatan tersebut akan dievaluasi setiap satu bulan sekali, sehingga bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran / penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi jadwal kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala instalasi.

BAB V. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan kegiatan di dalam program dilakukan dengan cara memasukkan pada laporan bulanan. Laporan program dibuat dengan memasukkan unsur-unsur SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja atau dengan cara merinci setiap program yang direncanakan. Laporan dibuat setiap satu bulan sekali, dan diserahkan kepada direktur.

Evaluasi pelaksanaan program kerja secara keseluruhan dilakukan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan atau dengan cara mencocokkan waktu pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan program. Evaluasi pelaksanaan program kerja dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

BAB VI PENUTUP

Demikian program kerja unit Kamar Operasi disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Mengetahui

Kepala Instalasi Kamar operasi



dr. Robby, Sp.An-Ti

Pasuruan, 17 November 2025

Kepala Ruang Kamar operasi



Rizky Dwi Ramadhani Amd. Kep

Menyetujui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep